

DLBCL / CNSL 新治疗与机制文 献监测

近 7 天官方 PubMed 窗口：2026-06-06 至 2026-06-12。每篇文章单独成页，按“标题、结论、主要内容、关键信息、启示”快速浏览；启示严格区分已验证证据、作者观点和我的推断。

EDAT 新入库 38	PDAT 发表日期 33	MDAT 记录更新 274	精选入页 5
----------------	-----------------	------------------	-----------

固定公网主页：<https://zhengyi-pharmacy-collab.github.io/pubmed-lymphoma-slides/>

[下载 PDF](#) [下载 PPTX](#)

检索与筛选说明

PubMed 官方 ESearch/EFetch 于 2026-06-12 检索；窗口为 2026-06-06 至 2026-06-12，合并 EDAT、PDAT、MDAT 覆盖近 7 天新增、发表和记录更新。官方计数为 EDAT 38、PDAT 33、MDAT 274，去重候选池 280 条。本日沿用 5 papers/day 和 pubmed-history.json 去重，选择 5 篇未跨日重复 PMID；EDAT/PDAT 优先，PDAT-only 条目明确标注为发表日期命中而非新入库。

检索式：((DLBCL[Title/Abstract] OR "diffuse large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR "large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR LBCL[Title/Abstract] OR PCNSL[Title/Abstract] OR "primary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "primary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR CNSL[Title/Abstract] OR "central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract]) AND lymphoma[Title/Abstract])

覆盖方向：BTKi、双抗、CAR-T/细胞治疗、ADC、免疫治疗、靶向联合、病例/病例系列、基础/机制/转化、耐药、CNS 穿透/药代、安全性和真实世界。

#	方向	疾病	PMID	标题	打开链接
1	CNS 预防 / 高危 LBCL / 回顾队列	超高危 large B-cell lymphoma	42274647	超高危 LBCL 的 HD-MTX CNS 预防：大型国际回顾数据未显示显著降低 CNS 复发	打开文献
2	双抗 / R/R DLBCL / 3 年随访	ASCT 不适合 R/R DLBCL	42269085	STARGLO 3 年随访：Glofitamab-GemOx 在 ASCT 不适合 R/R DLBCL 中维持 OS/PFS 优势	打开文献
3	CAR-T / 药代 / 淋巴清除	R/R LBCL	42269079	CAR-T 淋巴清除 PK：氟达拉滨 AUC 最优窗口与 R/R LBCL 的 PFS 延长相关	打开文献
4	机制 / 微环境 / 抗 CD20 联合策略	DLBCL	42270158	HMGB2-TRIM65-NLRP3 轴：DLBCL 细胞通过重塑巨噬细胞促进免疫抑制和进展	打开文献
5	CAR-T / 双抗 / ADC / 研究设计综述	R/R LBCL	41871044	R/R LBCL 新疗法蓝图：CAR-T、双抗、ADC 已推动疗法迭代，但证据基础设施滞后	打开文献

PMID 42274647

打开 PubMed 文献

超高危 LBCL 的 HD-MTX CNS 预防：大型国际回顾数据未显示显著降低 CNS 复发

High-Dose Methotrexate as CNS Prophylaxis in Ultra High-Risk Large B-Cell Lymphoma: An International Multicenter Analysis.

CNS 预防 / 高危 LBCL / 回顾队列

超高危 large B-cell lymphoma

EDAT/PDAT/MDAT 命中：2026-06-12 近 7 天新增/发表

P CNS-IPI 5-6、特定高危结外部位或多结外受累的高危 LBCL 患者

I 高剂量甲氨蝶呤作为 CNS 预防

C 未接受 HD-MTX CNS 预防

O 3 年 CNS 复发、孤立 CNS 复发、6 个月 landmark CNS 复发

结论

这项 JCO 国际多中心分析合并 1,923 例超高危 LBCL 患者，比较是否接受高剂量甲氨蝶呤 (HD-MTX) CNS 预防。3 年 CNS 复发率在未用 HD-MTX 与使用 HD-MTX 人群中分别为 9.3% 与 8.1%，校正后 HR 1.13，未见显著差异；孤立 CNS 复发和 6 个月 landmark 分析也未显示获益。它强化了“CNS 复发预防不能只靠惯性加 HD-MTX”的研究设计信号。

主要内容

- 研究对象为满足超高危标准的 LBCL 患者：CNS-IPI 5-6、睾丸/肾上腺/乳腺受累，或 3 个及以上结外部位。
- 主要终点是从诊断起计算的 CNS 复发率，包括孤立 CNS 复发或伴系统性复发的 CNS 复发。
- 全队列中，no HD-MTX n=1,051，HD-MTX n=872；3 年 CNS 复发率 9.3% vs 8.1%，校正 HR 1.13 (95% CI 0.82-1.57)。
- 6 个月无进展应答者的 landmark 分析中，3 年 CNS 复发率 6.7% vs 6.6%，校正 HR 0.95 (95% CI 0.62-1.44)。

关键信息

- 作者：Matthew R Wilson、Katharine L Lewis、Amy A Kirkwood、Kate Cwynarski、Chan Y Cheah、Tarec C El-Galaly 等。
- 核心数据：1,923 例超高危 LBCL；孤立 CNS 复发 5.9% vs 5.7%，校正 HR 1.03；各超高危亚组未提示显著 CNS 复发下降。
- 临床研究价值：这是关于 UHR-LBCL HD-MTX CNS 预防的最大国际比较数据集之一，直接回应 CNS 预防策略的证据缺口。
- 方向标签：LBCL、DLBCL 相关 CNS relapse、HD-MTX、CNS prophylaxis、ultra high-risk、retrospective comparative analysis。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要明确记录了样本量、UHR 标准、3 年 CNS 复发率、孤立 CNS 复发率和 landmark 分析，均未显示 HD-MTX 显著降低 CNS 复发。

论文作者观点

论文作者观点：尽管回顾性分析存在固有限制，这些数据强烈支持既往研究，即 HD-MTX CNS 预防对多数超高危 LBCL 患者没有有意义获益。

我的推断

我的推断：后续 CNS 预防研究应转向更精细的风险分层、药物 CNS 暴露、分子/影像风险模型和前瞻设计；不能把本研究解读为所有个体都无需 CNS 预防。

PMID 42269085

打开 PubMed 文献

STARGLO 3 年随访：Glofitamab-GemOx 在 ASCT 不适合 R/R DLBCL 中维持 OS/PFS 优势

Glofitamab plus gemcitabine and oxaliplatin for relapsed/refractory DLBCL: 3-year follow-up of STARGLO.

双抗 / R/R DLBCL / 3 年随访	ASCT 不适合 R/R DLBCL	EDAT/PDAT/MDAT 命中: 2026-06-12 近 7 天新增/发表
P ASCT 不适合的 R/R DLBCL 患者，含二线、三线及以后、老年和早期复发亚组	I glofitamab + gemcitabine + oxaliplatin	C rituximab + gemcitabine + oxaliplatin
O OS、PFS、CR、亚组疗效和长期安全性		

结论

STARGLO III 期研究 3 年随访显示，固定疗程 glofitamab + GemOx 相比 R-GemOx 在 ASCT 不适合 R/R DLBCL 中持续带来 OS、PFS 和 CR 优势。中位 OS 25.5 vs 12.5 个月，HR 0.60；中位 PFS 14.4 vs 3.3 个月，HR 0.41；CR 率 58.5% vs 25.3%。疗效在二线、老年和早期复发/原发难治亚组中仍有信号，且未发现新的安全性信号。

主要内容

- 研究背景：STARGLO 已证明 Glofit-GemOx 相比 R-GemOx 改善 ASCT 不适合 R/R DLBCL 的总生存；本次是 3 年随访更新。
- 数据截止 2025-05-01，中位 OS 随访 35.1 个月；Glofit-GemOx 的中位 OS 为 25.5 个月，R-GemOx 为 12.5 个月。
- PFS 与 CR 也持续分离：中位 PFS 14.4 vs 3.3 个月，CR 率 58.5% vs 25.3%。
- 二线人群和早期治疗失败/原发难治人群中获益更突出；≥75 岁老年患者也观察到一致疗效，未报告新的安全性信号。

关键信息

- 作者：Jeremy S Abramson、William Townsend、Christopher P Fox、Matthew Ku、Mark Hertzberg、Hui-Qiang Huang 等。
- 核心数据：OS HR 0.60；PFS HR 0.41；CR 率 58.5% vs 25.3%；二线 3 年 OS 率 54.6%，三线及以后 33.2%。
- 方案特征：off-the-shelf CD20xCD3 双抗联合 GemOx，固定疗程，面向 ASCT 不适合 R/R DLBCL。
- 方向标签：glofitamab、CD20xCD3 bispecific、GemOx、R/R DLBCL、STARGLO、elderly、early relapse。

启示

已验证证据 已验证证据：PubMed 摘要记录了 III 期 STARGLO、3 年随访、OS/PFS/CR 数值、二线及老年亚组一致性和无新增安全性信号。	论文作者观点 论文作者观点：固定疗程 Glofit-GemOx 在 ASCT 不适合 R/R DLBCL 中持续优于 R-GemOx，支持其作为有效的即用型治疗方案，并提示二线场景潜力。	我的推断 我的推断：双抗联合化疗的后续研究重点会从“是否有效”转向二线定位、老年/不可移植人群路径、固定疗程停药标准和与 CAR-T/ADC 的序贯关系。
---	--	--

CAR-T 淋巴清除 PK：氟达拉滨 AUC 最优窗口与 R/R LBCL 的 PFS 延长相关

PMID 42269079

打开 PubMed 文献

Impact of fludarabine exposure on CAR T-cell outcomes in patients with large B-cell lymphoma.

CAR-T / 药代 / 淋巴清除

R/R LBCL

EDAT/PDAT/MDAT 命中：2026-06-12 近 7 天新增/发表



接受商业 CD19 CAR-T 的 R/R LBCL 患者



淋巴清除期间测量并建模氟达拉滨 AUC 暴露



产品特异最优 AUC 窗口内 vs 窗口外



PFS、CAR-T 扩增、CRS、ICANS、血液毒性

结论

这项前瞻性单中心研究在 54 例接受商业 CD19 CAR-T 的 R/R LBCL 患者中测量氟达拉滨暴露，发现产品特异的 AUC 最优窗口与更长 PFS 独立相关。axi-cel 的最优 AUC 为 17.5-21.5 mg*h/L，tisa-cel 为 14.0-18.0 mg*h/L；处于最优窗口者中位 PFS 未达到，其他患者为 13.3 个月。研究把 CAR-T 前处理从固定剂量推进到 PK 指导剂量的假设层面。

主要内容

- 研究对象为 R/R LBCL，接受商业 CD19 CAR-T；淋巴清除期间每例最多采集 7 个血浆样本估计氟达拉滨 AUC。
- 中位随访 24.5 个月，中位氟达拉滨 AUC 为 18.12 mg*h/L；24 例（44%）落入产品特异最优 AUC 窗口。
- 最优窗口内患者的中位 PFS 未达到，其他患者为 13.3 个月（p=0.03）；多变量分析中最优暴露仍独立关联较好 PFS。
- CAR-T 扩增以及任意级 CRS、ICANS、血液毒性发生率在最优窗口与其他人群之间相似。

关键信息

- 作者：Mario Andrés Sánchez-Salinas、Javier Varela-Gonzalez-Aller、Gloria Iacoboni、Victor Navarro、Iñaki F Troconiz、Cecilia Carpio 等。
- 核心数据：54 例；axi-cel AUC 17.5-21.5 mg*h/L、tisa-cel AUC 14.0-18.0 mg*h/L；最优暴露与 PFS 改善相关。
- 研究价值：把淋巴清除强度、药代暴露和 CAR-T 结局连接起来，提示前处理剂量可能成为可优化变量。
- 方向标签：CD19 CAR-T、fludarabine exposure、AUC、lymphodepletion、axi-cel、tisa-cel、R/R LBCL、PK-guided dosing。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要明确给出样本量、采样策略、AUC 范围、PFS 差异、多变量结果，以及 CRS/ICANS/血液毒性未见明显增加。

论文作者观点

论文作者观点：前瞻性测量氟达拉滨暴露可识别与 PFS 延长相关的最优 AUC 窗口，支持整合 PK 指导氟达拉滨给药以提升 CAR-T 结局。

我的推断

我的推断：后续 CAR-T 研究设计应记录前处理真实暴露、肾功能、产品类型和扩增动力学；但目前仍是单中心 54 例研究，不能直接写成标准给药规则。

HMGB2-TRIM65-NLRP3 轴：DLBCL 细胞通过重塑巨噬细胞促进免疫抑制和进展

PMID 42270158

打开 PubMed 文献

Tumor-derived HMGB2 induces M2-like macrophage polarization via TRIM65-mediated NLRP3 degradation to promote DLBCL progression.

机制 / 微环境 / 抗 CD20 联合策略

DLBCL

EDAT/PDAT/MDAT 命中；2026-06-12 近 7 天新增/发表

P DLBCL 公共数据库、实验样本、细胞系和小鼠模型

I HMGB2 knockdown 或靶向 HMGB2-TRIM65-NLRP3 轴

C HMGB2 保留/高表达模型或未靶向该轴的对照

O 肿瘤进展、巨噬细胞极化、吞噬功能、CD20 免疫治疗协同效应

结论

这项 JITC 研究显示，DLBCL 细胞来源的外泌体 HMGB2 上调巨噬细胞 TRIM65，促进 NLRP3 炎症小体泛素化降解，驱动 M2-like 巨噬细胞极化并削弱吞噬功能。靶向该轴可恢复巨噬细胞吞噬，并与 CD20 免疫治疗协同增强抗肿瘤效应。它提供了一个把治疗抵抗、肿瘤微环境和抗 CD20 增敏连接起来的转化机制。

主要内容

- 研究先在公共数据库和实验样本中确认 HMGB2 在 DLBCL 中过表达并与较差预后相关。
- 体外 HMGB2 knockdown 未显示明显细胞内在效应，但体内显著抑制肿瘤进展，提示关键作用来自微环境重塑。
- 机制链条为：DLBCL 外泌体 HMGB2 -> 巨噬细胞 TRIM65 上调 -> NLRP3 泛素化降解 -> M2-like 极化和吞噬功能受损。
- 治疗层面，靶向该轴可恢复巨噬细胞吞噬，并与 CD20 免疫治疗产生协同抗肿瘤效应。

关键信息

- 作者：Sanxiu He、Yi Liu、Yifeng Tang、Liuyue Zhai、Xin Luo、Mingyu Zhao 等。
- 核心技术：体内/体外 knockdown 模型、巨噬细胞-DLBCL 共培养、转录组、co-IP、免疫荧光、外泌体分离和蛋白酶保护实验。
- 机制价值：把 HMGB2 从“高表达预后标志”推进到“外泌体介导微环境免疫抑制”的可干预轴。
- 方向标签：HMGB2、TRIM65、NLRP3、macrophage polarization、phagocytosis、CD20 immunotherapy、therapy resistance。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要记录了 HMGB2 过表达、体内抑瘤、TRIM65-NLRP3 机制、M2-like 极化、吞噬功能受损及与 CD20 免疫治疗协同。

论文作者观点

论文作者观点：HMGB2-TRIM65-NLRP3 轴是 DLBCL 中关键免疫抑制通路，靶向该轴可能重编程微环境并克服治疗抵抗。

我的推断

我的推断：这类机制研究适合转化为抗 CD20、双抗或巨噬细胞功能增强联合假设；但目前主要是机制和模型证据，不应写成已验证临床疗效。

R/R LBCL 新疗法蓝图：CAR-T、双抗、ADC 已推动疗法迭代，但证据基础设施滞后

PMID 41871044

打开 PubMed 文献

From breakthroughs to blueprints: evolving evidence and future directions in relapsed and refractory large B-cell lymphoma.

CAR-T / 双抗 / ADC / 研究设计综述

R/R LBCL

PDAT/MDAT 命中：2026-06-12 近 7 天发表日期命中，非 EDAT 新入库

P R/R LBCL 患者及相关临床试验证据体系

I CAR-T、双抗、ADC、双抗-ADC 组合、dual-target CAR-T 等新疗法路径

C 传统化疗对照、既往证据框架和当前 CAR-T 标准

O 疗效解释、治疗序贯、证据可解释性、可及性和未来试验设计

结论

这篇 Blood 综述认为，R/R LBCL 的治疗格局已被细胞治疗、双特异性抗体和新一代 ADC 快速重塑；随机研究显示 ADC 或双抗锚定方案可优于传统化疗对照，但证据解释受地区异质性、选择性入组和缺乏当代对照臂影响。下一代方向包括双抗-ADC 组合、dual-target CAR-T 和抗原逃逸规避策略；真正瓶颈正在从“有没有活性药物”转向“如何建立可解释、可及、可更新的证据路径”。

主要内容

- 综述覆盖 R/R LBCL 中细胞治疗、CD20xCD3 双抗和 ADC 的证据演进，并强调它们正在挑战传统治疗层级。
- 作者指出，近期随机研究提示 ADC-anchored 和 bispecific-anchored 方案可优于 legacy chemotherapy comparators。
- 证据局限包括地理异质性、选择性入组、缺乏当代标准对照臂，以及标准治疗变化快于试验设计更新。
- 未来研究应包括与当前 CAR-T 标准一致的对照臂、统一入排标准、前瞻分子分型和可随标准治疗变化的 adaptive platform。

关键信息

- 作者：Manali Kamdar、Nancy L Bartlett。
- 核心观点：治疗创新速度超过证据基础设施建设速度，R/R LBCL 需要生物学合理、可及、可解释的路径。
- 覆盖技术：CAR-T、dual-target CAR-T、CD20xCD3 双抗、ADC、bispecific-ADC combinations、抗原逃逸规避策略。
- 方向标签：R/R LBCL、cellular therapy、bispecific antibody、ADC、trial design、sequencing、access、molecular profiling。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要明确列出 CAR-T、双抗、ADC、双抗-ADC 组合、dual-target CAR-T、抗原逃逸和试验设计基础设施等主题。

论文作者观点

论文作者观点：领域已到拐点，需用当代对照臂、统一入组、前瞻分子分型和自适应平台来支撑疗法更早线和社区实践扩散。

我的推断

我的推断：每日监测中应把单药/单研究结果放到序贯路径里解读，优先标记能改变对照臂、入组分层、可及性或联合策略设计的证据。

今天的信号不是单一药物热点，而是“疗效前移 + 治疗可及 + CNS/微环境分层 + 安全管理”同步推进

已验证证据 本轮官方候选池 280 条，精选 5 篇未跨日重复 PMID： 42274647、42269085、42269079、42270158、41871044。 覆盖 CNS 预防、CD20xCD3 双抗、CAR-T 前处理药代、DLBCL 巨噬细胞免疫抑制机制，以及 R/R LBCL 中 CAR-T/双抗/ADC 证据蓝图。	论文作者观点 入选论文作者共同强调的方向是：LBCL/DLBCL 研究正在从单一疗效率转向风险分层、长期随访、药代可优化变量、微环境机制、治疗序贯和更符合当代标准的试验设计。	我的推断 我的推断是，后续监测应优先捕捉能改变研究设计变量的条目：CNS relapse 真实风险与预防策略、双抗/ADC/CAR-T 的二线或不可移植路径、CAR-T 前处理暴露优化、以及可与免疫治疗联合的微环境靶点。病例报告仍需保留雷达，但优先级低于能改变方案设计的队列、随机研究和转化机制。
下一次优先跟进 继续观察 frontMIND OS/ctDNA、PCNSL 双抗 CNS 穿透验证、双抗治疗中 PET 动态指标、CAR-T 可及性和桥接前 MTV 变化。	设计启示 DLBCL/CNSL 研究应同时记录疗效、到达治疗的路径、CNS/CSF 指标、影像负荷、分子/微环境分层和感染/神经毒性安全窗口。	边界提醒 本页仅作文献监测、证据摘要和方案设计启示整理，不提供医疗建议，也不生成治疗推荐。